

Riesgo Cardiovascular en Colombia 2026

Un caso clínico integrador basado en **PREVENT™**, **ApoB**, **Lp(a)** y la Guía ACC/AHA 2026



Dr. Jaime Gómez- Md especialista en medicina interna

Dr. Sergio Gómez- Md residente en medicina interna

Historia del Paciente

Identificación

Masculino, 48 años ·
Bucaramanga ·
Administrador de
empresas

Motivo de Consulta

"La presión arterial
continúa elevada pese al
tratamiento."

Antecedentes

- HTA hace 3 años ·
Dislipidemia no
tratada
- Exfumador 20
paquetes-año
(suspendió hace 5
años)
- Padre: IAM a los 54
años · Madre: DM2 ·
Hermano: HTA

Medicación

Losartán 50 mg/día

¹ Grundy SM et al. 2019 ACC/AHA Guideline on Cardiovascular Risk. Circulation. 2019;139:e1082–e1143.



ACTO I · ENFERMEDAD ACTUAL

Cuadro Clínico

Paciente remitido por HTA con control subóptimo. Presenta **aumento progresivo de peso** (12 kg en 10 años), **fatiga al esfuerzo, disnea** al subir escaleras y **episodios de opresión retroesternal leve** con el esfuerzo o estrés emocional de resolución espontánea. Ronquido intenso, sueño no reparador y somnolencia diurna.

Cardiovascular

Opresión torácica ocasional con
esfuerzo · 18 meses de evolución

Respiratorio

Ronquido · Sueño fragmentado ·
Somnolencia diurna

Metabólico

Aumento progresivo del perímetro
abdominal

¹ Grundy SM et al. 2019 ACC/AHA Guideline on Cardiovascular Risk. *Circulation*. 2019;139:e1082–e1143.

ACTO I · EXAMEN FÍSICO Y PARACLÍNICOS

Hallazgos Objetivos

Examen Físico

- TA: 142/88 mmHg · FC: 78 lpm
- Peso: 102 kg · Talla: 1.74 m · **IMC: 33.7 kg/m²**
- Circunferencia abdominal: **112 cm**
- SpO₂: 97% · Sin edema · Sin soplos

Paraclínicos

- Glucosa: 108 mg/dL · HbA1c: 6.0%
- CT: 246 · **LDL: 158** · HDL: 38 · TG: 246 mg/dL
- PCR-us: 3.5 mg/L · TFGe: 96 ml/min
- ECG: Ritmo sinusal, sin alteraciones isquémicas

¹ Grundy SM et al. 2019 ACC/AHA Guideline on Cardiovascular Risk. *Circulation*. 2019;139:e1082–e1143.

PREGUNTA 1

¿Cuál es el principal problema clínico?

1

A

Hipertensión arterial aislada

2

B

Obesidad aislada

3

C ☒

Acumulación simultánea de múltiples factores de riesgo cardiovascular

4

D

Dislipidemia aislada

² Arnett DK et al. 2019 ACC/AHA Guideline on Primary Prevention of CVD. J Am Coll Cardiol. 2019;74:e177–e232.



Interacción de Factores de Riesgo Cardiovascular

La aterosclerosis es consecuencia de la interacción prolongada entre múltiples factores que producen inflamación endotelial, remodelado vascular y formación progresiva de placa aterosclerótica.

² Arnett DK et al. 2019 ACC/AHA Guideline on Primary Prevention of CVD. *J Am Coll Cardiol*. 2019;74:e177–e232.

C: Múltiples Factores de Riesgo Simultáneos



Obesidad abdominal

IMC 33.7 · CA 112 cm



HTA + Dislipidemia

TA 142/88 · LDL 158 · TG 246



Antecedente familiar

Padre: IAM a los 54 años



Tabaquismo + AOS

20 paquetes-año · Ronquido severo

  A, B, D: Analizar un factor aislado subestima gravemente el riesgo global. La enfermedad CV es resultado de exposición acumulativa durante décadas.

² Arnett DK et al. 2019 ACC/AHA Guideline on Primary Prevention of CVD. J Am Coll Cardiol. 2019;74:e177–e232.

PREGUNTA 2

¿Cuál es el diagnóstico sindromático predominante?

1

A

Hipertensión arterial esencial

2

B ☒

Síndrome hipertensivo- hiperglicémico-metabólico

3

C

Enfermedad coronaria estable

4

D

Diabetes mellitus tipo 2

³ Alberti KG et al. Harmonizing the Metabolic Syndrome. *Circulation*. 2009;120:1640–1645.

Definiciones y Clasificaciones

Guía AHA 2026 para el manejo de dislipidemias — un cambio de paradigma conceptual

Dislipidemia

Enfermedad de **partículas aterogénicas**, no solo de colesterol

Síndrome CKM

Cardiovascular-Riñón-Metabólico:
un continuo fisiopatológico

ASCVD

Enfermedad cardiovascular aterosclerótica — con estratificación de riesgo

1. American Heart Association. 2026 AHA guideline for the management of dyslipidemia: executive summary. *Circulation*. 2026;[Epub ahead of print].

Metabolic syndrome



COMPARATIVA DE CALCULADORAS DE RIESGO CARDIOVASCULAR

CALCULADORA	SCORE2 Europa 	SCORE2-OP ≥70 años 	Pooled Cohort Equations EE. UU. 	PREVENT EE. UU. 	QRISK3 Reino Unido 	WHO Charts Global (ingresos bajos y medios) 
 POBLACIÓN	40–69 años	≥70 años	40–79 años	30–79 años	25–84 años	40–70 años
 VARIABLES PRINCIPALES	Edad, sexo, tabaquismo, PAS, colesterol total o no-HDL	Igual que SCORE2	Edad, sexo, raza, PAS, diabetes, tabaquismo, colesterol total y HDL	Edad, sexo, PAS, IMC, colesterol, diabetes, tabaquismo, TFG	>20 variables (incluye ERC, AR, corticoides, migraña, antecedente familiar)	Edad, sexo, tabaquismo, PAS, diabetes, colesterol (o sin colesterol)
 PREDICE	Evento CV fatal y no fatal	Evento CV fatal y no fatal	ASCVD (IAM, ACV)	ECV, IC y mortalidad	IAM y ACV	IAM y ACV
 HORIZONTE	10 años	5–10 años	10 años	10 y 30 años	10 años	10 años
 VENTAJAS	Ajustada por regiones europeas	Diseñada para adultos mayores	Base para decisiones terapéuticas (estatinas)	No utiliza raza Incluye ERC Predice eventos y mortalidad	Muy completo Buena discriminación en Reino Unido	Adaptada a múltiples regiones Versión sin laboratorio
 LIMITACIONES	Requiere elegir la región de riesgo correcta	Validada solo en Europa	Puede sobreestimar en algunas etnias	Validación internacional en curso	Complejo para uso fuera de Reino Unido	Menor precisión individual
 GUÍA QUE LA RECOMIENDA	ESC 2021	ESC 2021	ACC/AHA 2018–2024	ACC/AHA 2023–2024	NICE 2014 (actual. 2023)	WHO 2007 (actual. 2019)

Archivos de Medicina
Artículo de Investigación

Evaluación del riesgo cardiovascular mediante la escala PREVENT en adultos mayores del noroccidente de Colombia, 2014-2024

JORGE ANDRES HERNANDEZ -NAVAS¹, LUIS DULCEY-SARMIENTO²,
JAIME GÓMEZ- AYALA³, JUAN THERÁN -LEÓN⁴, LUIS TOSCANO-DULCEY⁵.

Recibido para publicación: 21-07-2025. Versión corregida: 01-09-2025. Aprobado para publicación: 02-03-2025.

Modelo de citación:

Hernandez -Navas J.A., Dulcey-Sarmiento L., Gómez- Ayala J., Therán -León J., Toscano-Dulcey L. Evaluación del riesgo cardiovascular mediante la escala PREVENT en adultos mayores del noroccidente de Colombia, 2014-2024. Arch Med (Manizales). 2026;26(1). <https://doi.org/10.30554/archmed.26.1.5448.2026>

Resumen

Introducción: Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad a nivel global, con un incremento significativo en las últimas décadas. La escala PREVENT, desarrollada por la American Heart Association, busca mejorar la predicción del riesgo cardiovascular considerando cambios epidemiológicos y nuevos factores de riesgo. Su validación externa es fundamental para garantizar su aplicabilidad en poblaciones específicas como la colombiana. Objetivo: Evaluar la calibración y discriminación de la escala PREVENT en la estimación del riesgo cardiovascular en adultos mayores del noroccidente de Colombia y compararla con el modelo de cohortes agrupadas. Materiales y métodos: Se realizó un estudio de cohorte prospectivo con datos de salud pública de Bucaramanga (Santander, Colombia). Se incluyeron variables demográficas, factores de riesgo cardiovasculares y mediciones antropométricas y bioquímicas en

Cálculo PREVENT™

Resultado PREVENT™

6.02 %

10-Year Total CVD Risk

10-Year ASCVD Risk: 4.32%

10-Year Heart Failure Risk: 2.04%

10-Year Coronary Heart Disease Risk: 2.77%

10-Year Stroke Risk: 1.51%

31.68 %

30-Year Total CVD Risk

30-Year ASCVD Risk: 22.41%

30-Year Heart Failure Risk: 15.33%

30-Year Coronary Heart Disease Risk: 15.67%

30-Year Stroke Risk: 8.75%

Pregunta 3

Según la guía ACC/AHA 2026, ¿cuál es el siguiente paso después de calcular PREVENT™?

- 1 Considerar bajo riesgo y finalizar el estudio
- 2 Solicitar cateterismo cardíaco
- 3 **Personalizar el riesgo buscando potenciadores** ✓
- 4 Iniciar inmediatamente inhibidor PCSK9

⁴ Khan SS et al. 2026 ACC/AHA Guideline on Primary Prevention of CVD. J Am Coll Cardiol. 2026.

Calculate and Classify

Estimate 10-y risk with
PREVENT-ASCVD

1

Low risk
0%–<3%

Borderline risk
3%–<5%

Intermediate risk
5%–<10%

High risk
≥10%

Personalize

Discuss risk estimate
and therapy options
with patient

1

Discuss risk estimate
and therapy options
with patient

1

AND

Evaluate risk enhancers

2a

Discuss risk estimate
and therapy options
with patient

1

Discuss risk estimate
and therapy options
with patient

1

Reclassify and Reassess

If clinical or patient
uncertainty, consider
CAC score and revise
results

1

If clinical or patient
uncertainty, consider
CAC score and revise
results

1

Decide and Treat

Lifestyle modification

1

Treat with lifestyle
modification and
potential lipid-lowering
therapy

2a

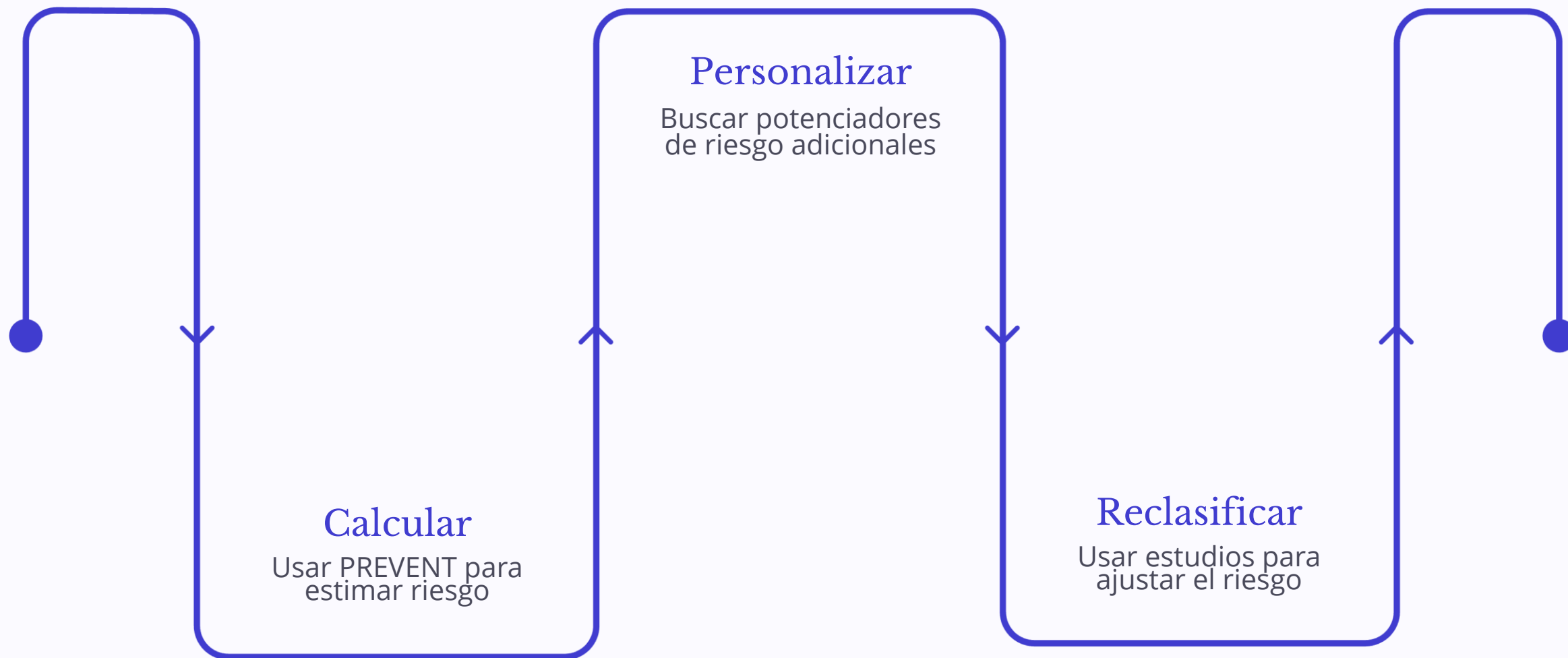
Lifestyle modification
and lipid-lowering
therapy

1

COR 1
COR 2a
COR 2b
COR 3-No Benefit
COR 3-Harm
(Class of Recommendation)



C: Calcular → Personalizar → Reclasificar



Muchos pacientes aparentemente de "bajo riesgo" son reclasificados al identificar factores no capturados por la calculadora. PREVENT no es el punto final del análisis.

⚠️ A: Error que corrige la nueva guía. ❌ B: No hay indicación invasiva. ❌ D: Estratificación incompleta.

⁴ Khan SS et al. 2026 ACC/AHA Guideline on Primary Prevention of CVD. J Am Coll Cardiol. 2026.

Biomarcadores Avanzados

Table 13. Risk Enhancers

Risk Enhancers
History of premature ASCVD in a parent or sibling (onset age <55 y for men, <65 y for women)
Higher risk ancestry (eg, South Asian, Filipino)
High polygenic risk (if measured) (Section 4.2.3.5, "Polygenic Risk Scores")
Chronic inflammatory diseases (eg, systemic lupus, rheumatoid arthritis, advanced psoriasis, inflammatory arthritis)
Lp(a) ≥ 125 nmol/L or ≥ 50 mg/dL
hsCRP ≥ 2 mg/L on >1 occasion (if measured)
TG persistently ≥ 175 mg/dL (2 mmol/L) (if nonfasting) and ≥ 150 mg/dL (1.7 mmol/L) (if fasting)
CKM syndrome
LDL-C persistently ≥ 160 – 189 mg/dL (4.1–4.9 mmol/L), non-HDL-C ≥ 190 – 219 mg/dL or apoB ≥ 120 mg/dL*
Reproductive risk markers (premature menopause, preeclampsia, gestational diabetes, gestational hypertension, preterm delivery; Section 4.2.3.4, "Reproductive Risk Marker")

132
ApoB (mg/dL)
Elevada carga aterogénica

3.5
PCR-us (mg/L)
Inflamación vascular activa

185
Lp(a) (nmol/L)
Riesgo aterotrombótico significativo

96
TFGe (ml/min)
Función renal normal

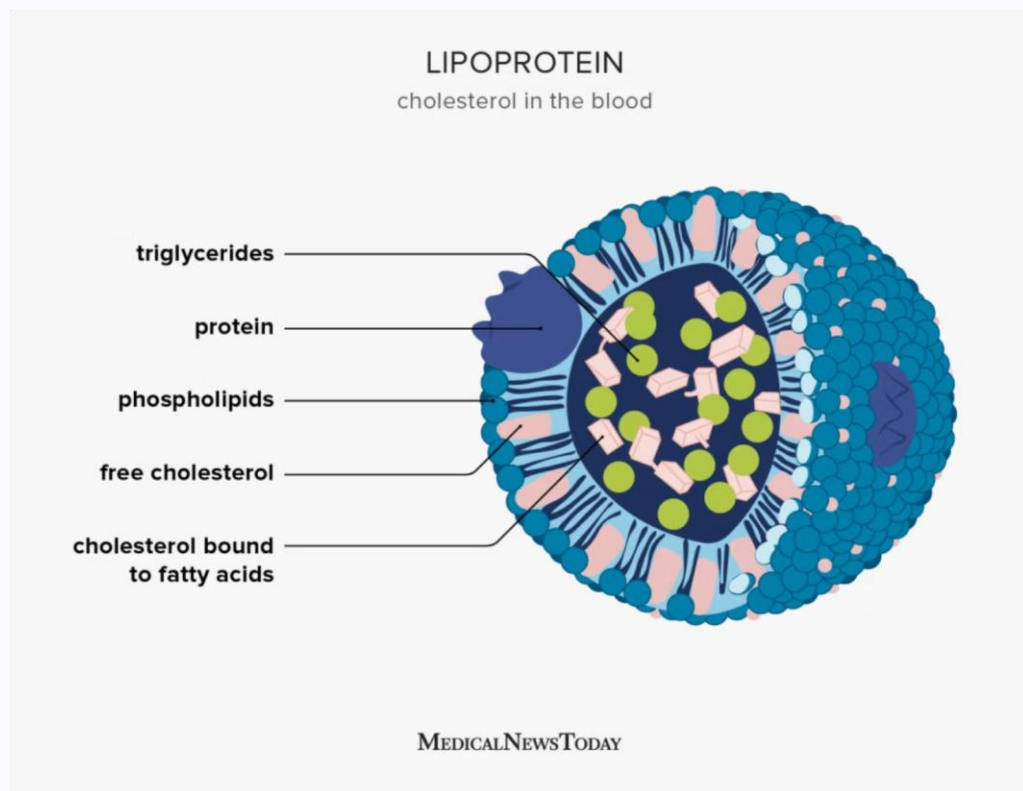
⁴ Khan SS et al. 2026 ACC/AHA Guideline on Primary Prevention of CVD. J Am Coll Cardiol. 2026.

Lipoprotein Goals for ASCVD Risk Reduction

Patient population	LDL-C <100 mg/dL (2.6 mmol/L) Non-HDL-C <130 mg/dL (3.4 mmol/L)	LDL-C <70 mg/dL (1.8 mmol/L) Non-HDL-C <100 mg/dL (2.6 mmol/L)	LDL-C <55 mg/dL (1.4 mmol/L) Non-HDL-C <85 mg/dL (2.2 mmol/L)
Primary prevention	PREVENT-ASCVD <10% • If TG ≥150 mg/dL to 499 mg/dL, apoB goal: <90 mg/dL	PREVENT-ASCVD ≥10% • If TG ≥150 mg/dL to 499 mg/dL, apoB goal: <70 mg/dL	N/A
Severe hypercholesterolemia	Without FH, ASCVD risk factors, and subclinical atherosclerosis	With FH, ASCVD risk factors, or subclinical atherosclerosis	Severe hypercholesterolemia or HeFH with clinical ASCVD
Diabetes	Without ASCVD risk factors or diabetes-specific risk modifiers • apoB goal: <90 mg/dL	With ASCVD risk factors or diabetes-specific risk factors • apoB goal: <70 mg/dL	N/A
Subclinical atherosclerosis	CAC = 1–99 AU and <75th percentile for age, sex, and race	• CAC ≥100 to 299 AU or ≥75th percentile for age, sex, race • CAC ≥300 to 999 AU ◦ Optional goal: LDL-C <55 mg/dL, non-HDL-C <85 mg/dL and consider apoB goal <55 mg/dL	CAC ≥1000 AU
Hypertriglyceridemia	<50 y old with no additional risk enhancers	• With clinical ASCVD not at very high risk ◦ apoB goal: <70 mg/dL • Age 40–75 y with ≥1 ASCVD risk factor ◦ apoB goal: <70 mg/dL	With clinical ASCVD at very high risk • apoB goal: <55 mg/dL
Clinical ASCVD	N/A	Not at very high risk • Optional goal: LDL-C <55 mg/dL, non-HDL-C <85 mg/dL and consider apoB goal <55 mg/dL	• At very high risk ◦ apoB goal: <55 mg/dL • With CKD

PREGUNTA 4

¿Cuál es un potenciador de riesgo cardiovascular reconocido?



1

A

Hemoglobina de 15.1 g/dL

2

B

Creatinina de 0.92 mg/dL

3

C ☒

Lipoproteína(a) elevada

4

D

ECG normal

⁵ Tsimikas S. A Test in Context: Lipoprotein(a). J Am Coll Cardiol. 2017;69:692–711.

PREGUNTA 4 · RESPUESTA



C: Lp(a) Elevada — 185 nmol/L



IAM y Coronariopatía Prematura



ACV y Enfermedad Arterial
Periférica



Estenosis Aórtica Calcificada



La guía ACC/AHA 2026 recomienda medir Lp(a) **al menos una vez** en todos los adultos. Tiene fuerte determinación genética e incrementa el riesgo independientemente del LDL.



✗ A: Hemoglobina normal. ✗ B: Función renal normal. ✗ D: ECG normal no excluye aterosclerosis subclínica.

⁵ Tsimikas S. A Test in Context: Lipoprotein(a). *J Am Coll Cardiol.* 2017;69:692–711.

PREGUNTA 5

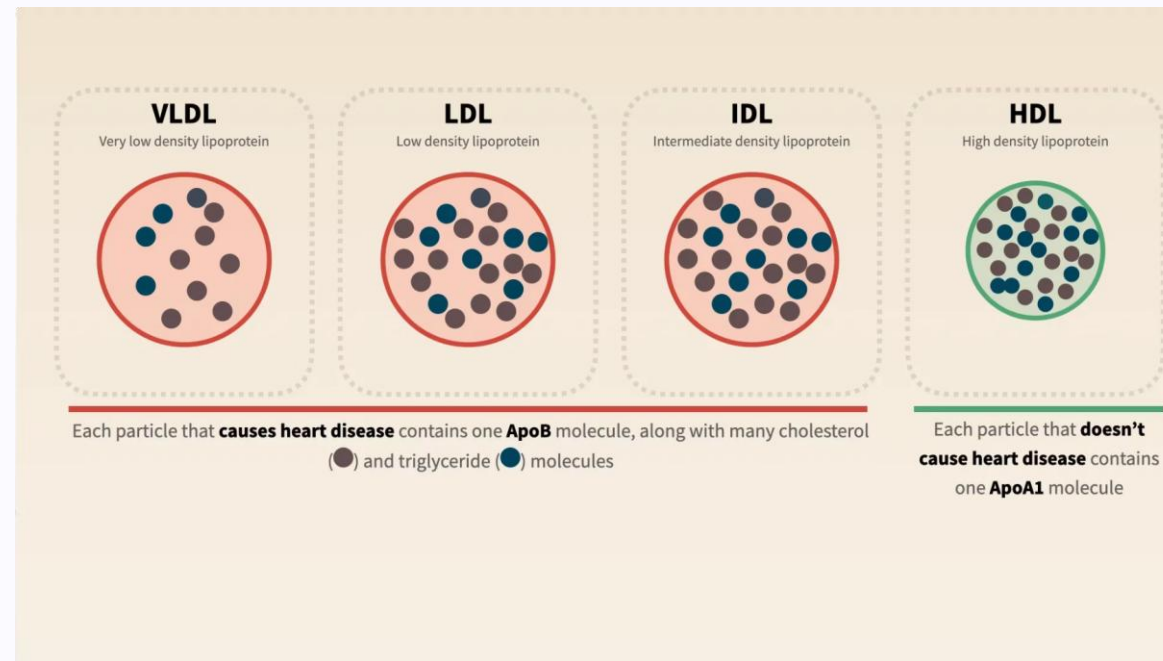
¿Qué representa una ApoB de 132 mg/dL?

1 A
Riesgo inflamatorio

2 B ☒
Elevada carga de partículas
aterogénicas

3 C
Enfermedad hepática

4 D
Riesgo hemorrágico



⁴ Khan SS et al. 2026 ACC/AHA Guideline on Primary Prevention of CVD. J Am Coll Cardiol. 2026.

PREGUNTA 5 · RESPUESTA

B: Elevada Carga de Partículas Aterogénicas

ApoB vs LDL

Cada partícula LDL contiene **una molécula de ApoB**. ApoB refleja mejor la carga aterogénica total.

Pacientes Clave

Especialmente importante en **obesidad, síndrome metabólico, DM2 e hipertrigliceridemia**.

Guía 2026

Incorpora ApoB como herramienta de **refinamiento del riesgo** cardiovascular.

  A: Inflamación → PCR-us.  C: ApoB no mide daño hepático.  D: Sin relación con riesgo hemorrágico.

⁴ Khan SS et al. 2026 ACC/AHA Guideline on Primary Prevention of CVD. J Am Coll Cardiol. 2026.

DECISIÓN TERAPÉUTICA

Perfil de Riesgo Completo → Acción

Factores Tradicionales

HTA · Obesidad ·
Dislipidemia ·
Prediabetes ·
Exfumador

Potenciadores de Riesgo

Lp(a) 185 nmol/L ·
ApoB 132 mg/dL · PCR-
us 3.5 mg/L · Historia
familiar · Síndrome
metabólico

Decisión Médico-Paciente

- **Rosuvastatina 20 mg/día**
- Dieta mediterránea
- Ejercicio aeróbico supervisado
- Pérdida ponderal
- Optimización tensional

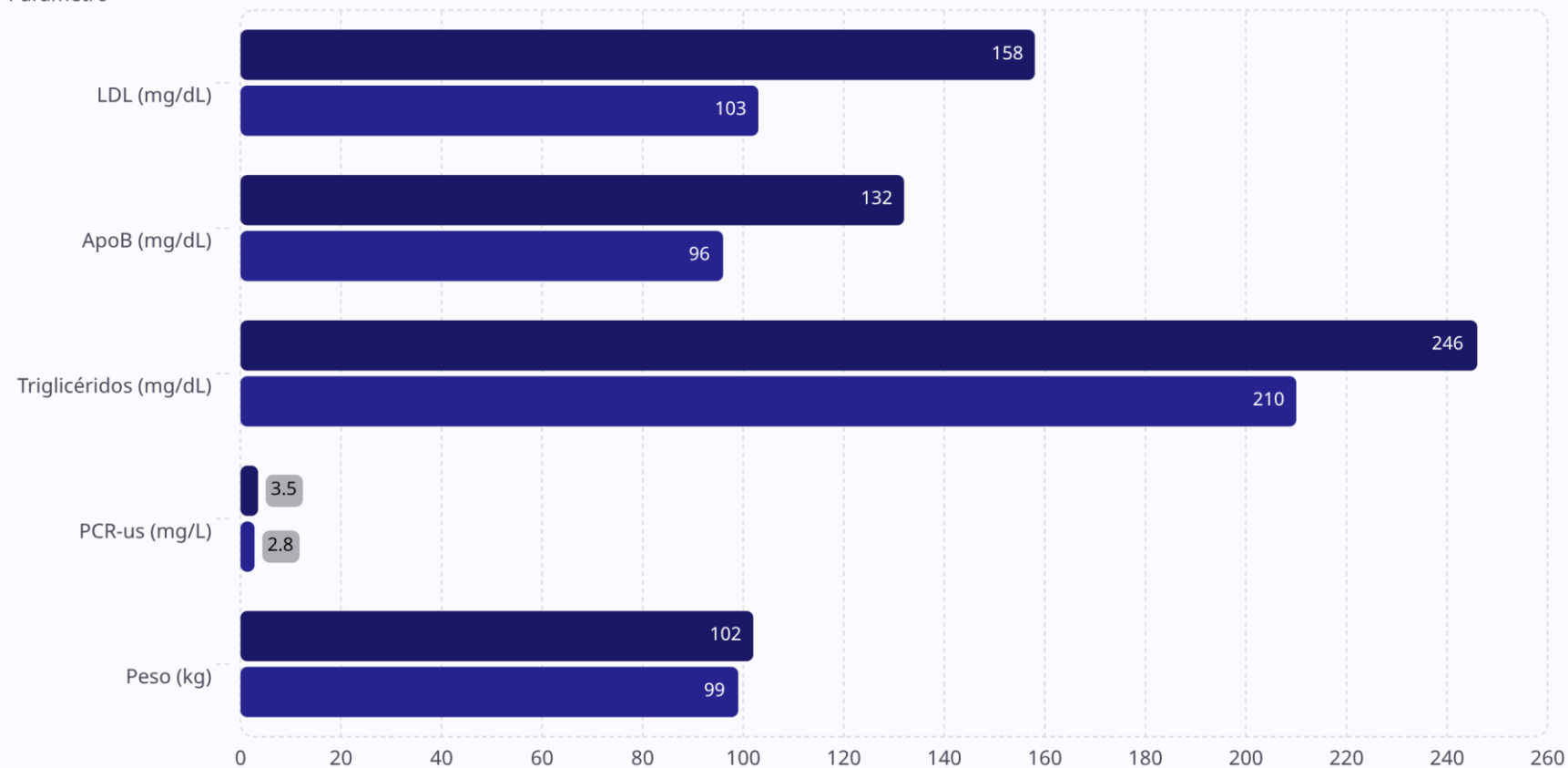
⁴ Khan SS et al. 2026 ACC/AHA Guideline on Primary Prevention of CVD. J Am Coll Cardiol. 2026.

CONTROL · 6 MESES DESPUÉS

Evolución del Paciente

■ Inicial ■ 6 Meses

Parámetro



⁴ Khan SS et al. 2026 ACC/AHA Guideline on Primary Prevention of CVD. J Am Coll Cardiol. 2026.

PREGUNTA 6

¿Cuál es la afirmación más correcta sobre la evolución?

1

A

El paciente alcanzó completamente sus metas terapéuticas

2

B ☒

La respuesta es adecuada pero todavía insuficiente para su perfil de riesgo

3

C

Debe suspenderse la rosuvastatina

4

D

No hubo respuesta al tratamiento

⁶ Mach F et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for Dyslipidaemias. Eur Heart J. 2020;41:111–188.

PREGUNTA 6 · RESPUESTA

✓ B: Mejoría Significativa, Pero Insuficiente

Logros ✓

- LDL: 158 → 103 mg/dL
- ApoB: 132 → 96 mg/dL
- Peso: 102 → 99 kg

Pendiente ⚠

- LDL aún sobre meta
- ApoB persiste elevada
- Múltiples potenciadores activos

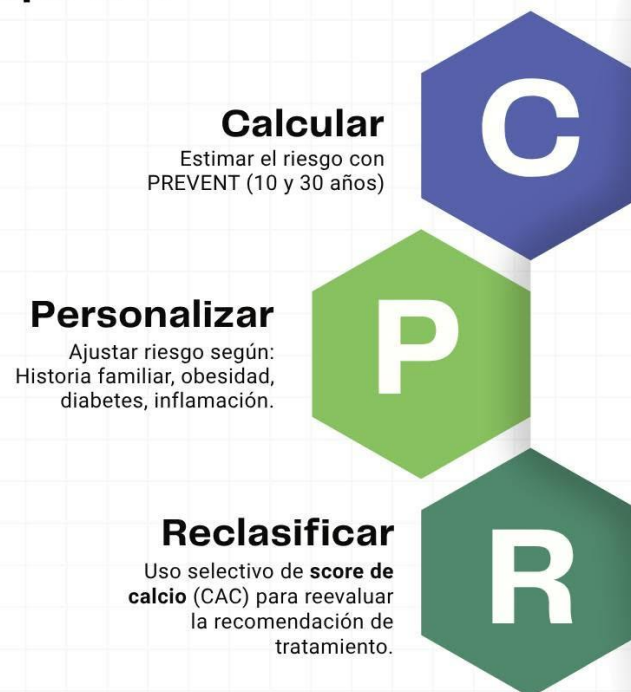
📌 **Próximo paso:** ¿Mantener rosuvastatina sola, agregar ezetimibe o solicitar score de calcio coronario?

⚠ **✗ A:** Carga residual considerable. **✗ C:** Suspender sería un error. **✗ D:** Reducción de LDL del 35% es respuesta real.

⁶ Mach F et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for Dyslipidaemias. Eur Heart J. 2020;41:111–188.

¿Cómo se evalúa ahora?

Nuevo enfoque CPR



www.nutrinfo.com

Acto IV: Reclasificación del Riesgo y Terapia Avanzada

¿Estamos subestimando el riesgo?



Hallazgos persistentes al 2.º control

- Historia familiar de EC prematura
- Lp(a) y ApoB elevadas
- PCR-us elevada
- Síntomas compatibles con angina estable
- Riesgo PREVENT aparentemente moderado

⚠ ¿El riesgo real está siendo subestimado?

PREGUNTA 7

¿Cuál es el siguiente paso más apropiado?

LDL: 103 mg/dL · ApoB elevada · Múltiples potenciadores de riesgo

A

Mantener rosuvastatina 20 mg como única terapia

B

Suspender tratamiento

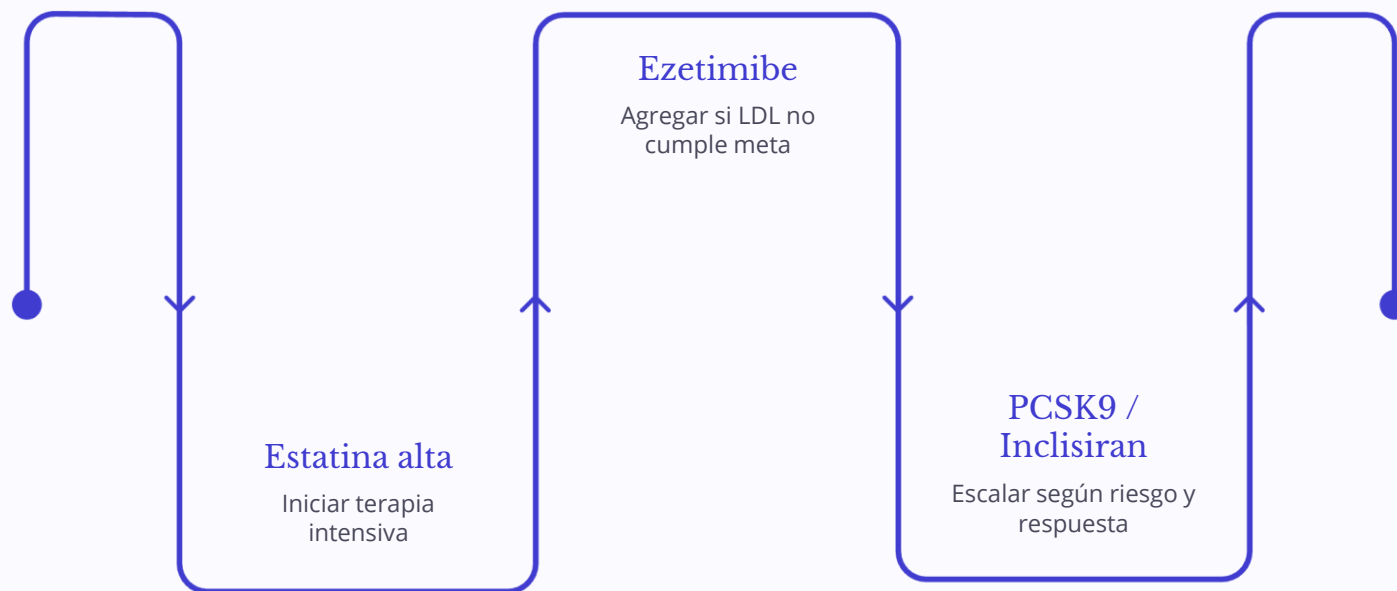
C ☒

Rosuvastatina 40 mg + Agregar ezetimibe

D

Solicitar cateterismo cardíaco

C. Agregar Ezetimibe



✗ A — Monoterapia

LDL y ApoB siguen sobre meta

✗ B — Suspende

Contradice toda la evidencia

✗ D — Cateterismo

Sin indicación invasiva actual

Guía ACC/AHA 2026: estrategia escalonada antes de avanzar a terapias más costosas.

1. Grundy SM et al. J Am Coll Cardiol. 2019;73(24):3168-3209.



Asociación Colombiana de
Neumología y Cirugía de Tórax



Control — 6 meses después

69

LDL mg/dL

74

ApoB mg/dL

2.4

PCR-us mg/L

95

Peso kg

Rosuvastatina 40 mg + Ezetimibe 10 mg · Buena adherencia · Mayor actividad física ·
Persisten dudas sobre carga aterosclerótica real



PREGUNTA 8

¿Qué estudio reclasifica el riesgo cardiovascular?

Según la guía ACC/AHA 2026

A

Holter

B

Ecocardiograma

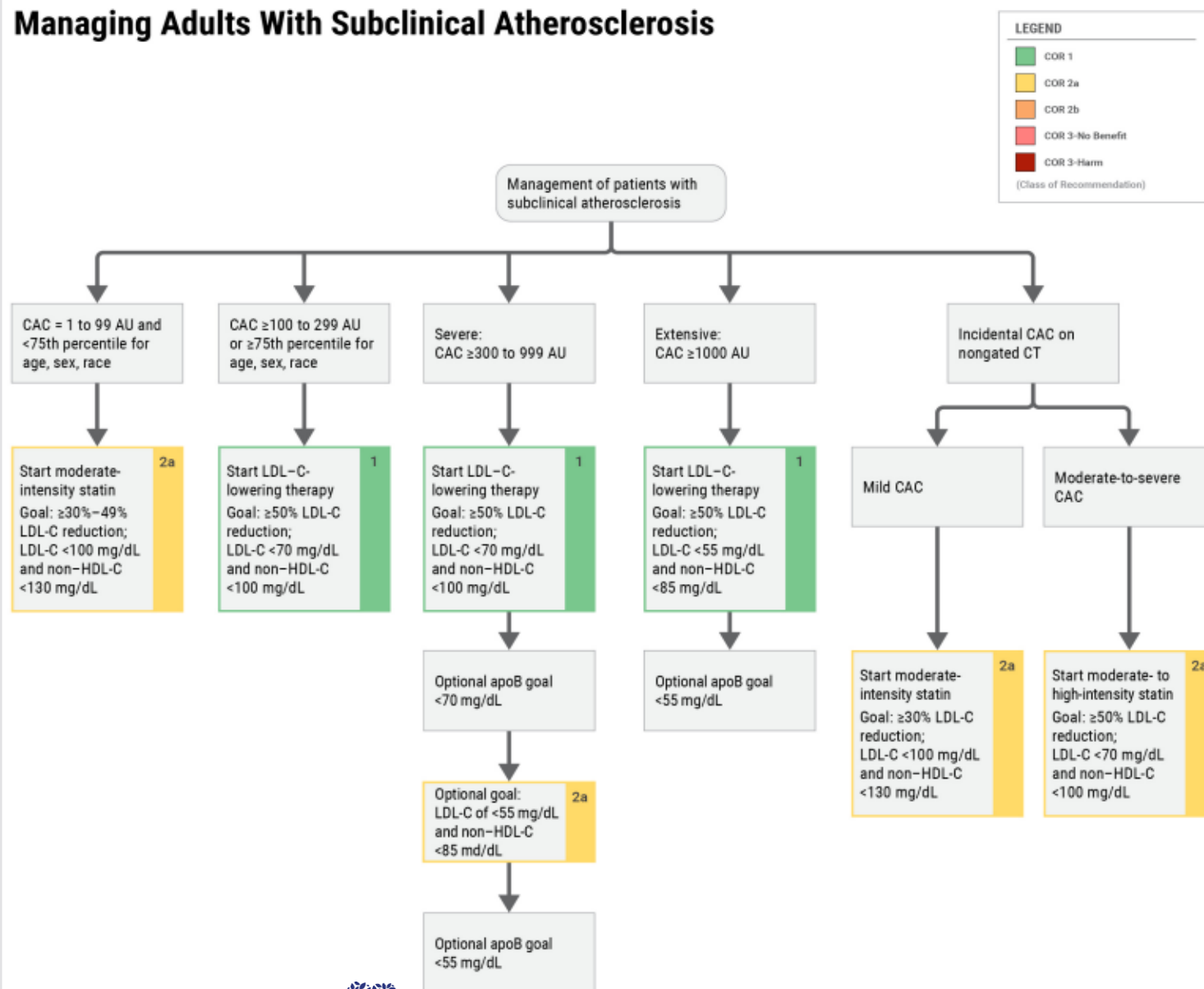
C ☒

Score de calcio coronario (CAC)

D

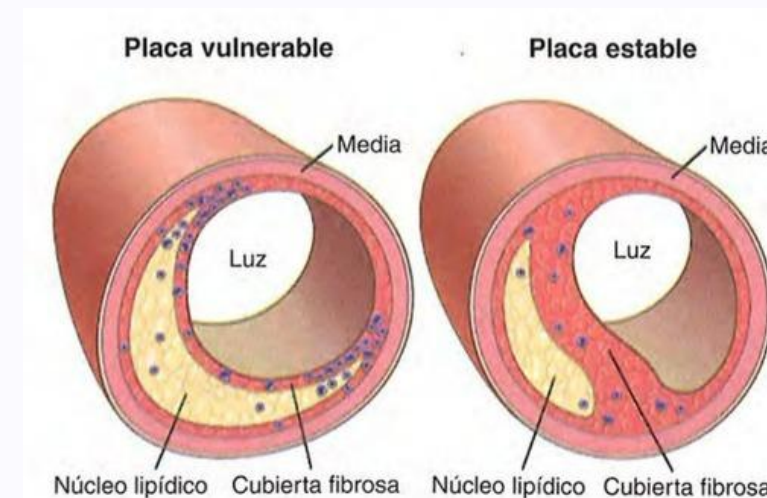
Resonancia cerebral

Managing Adults With Subclinical Atherosclerosis



El CAC permite:

- Detectar aterosclerosis subclínica
- Refinar decisiones terapéuticas
- Personalizar objetivos de LDL
- Identificar candidatos a tratamiento agresivo



CAC: 368 Agatston

Percentil >90 para edad y sexo

PREGUNTA 9

¿Cómo debe interpretarse este hallazgo?

A

Hallazgo incidental

B

Riesgo bajo

C ☒

Enfermedad aterosclerótica subclínica significativa

D

Normal para la edad

PREGUNTA 10

Acto V — Terapia Avanzada: ¿Siguiente paso?

A pesar de Rosuvastatina + Ezetimibe

69

LDL actual mg/dL

<55

Meta deseada mg/dL

Opciones terapéuticas

A

Mantener tratamiento
actual

B

Suspender estatina

C ☒

Agregar Evolocumab

D

Agregar fenofibrato

RESPUESTA 11

C. Agregar Evolocumab



Indicación clara:

- EC aterosclerótica demostrada
- CAC elevado (368 Agatston)
- LDL aún sobre meta (>55 mg/dL)

✓ Evolocumab reduce LDL ~60% adicional y disminuye eventos CV

✗ A: Metas sin alcanzar · ✗ B: Error terapéutico grave · ✗ D: Fenofibrato no es estrategia principal para LDL

5. Sabatine MS et al. *N Engl J Med.* 2017;376(18):1713-1722.

"¿Existe alternativa sin aplicaciones cada 15 días?"

31

LDL mg/dL a 18 meses

52

ApoB mg/dL

Sin eventos cardiovasculares · Sin infarto · Sin ACV

Opciones

A

Suspender tratamiento

B



Cambiar a Inclisiran

C

Disminuir dosis

D

Volver a monoterapia con estatina

B. Inclisiran — siRNA contra PCSK9



Día 0

Primera dosis inicial



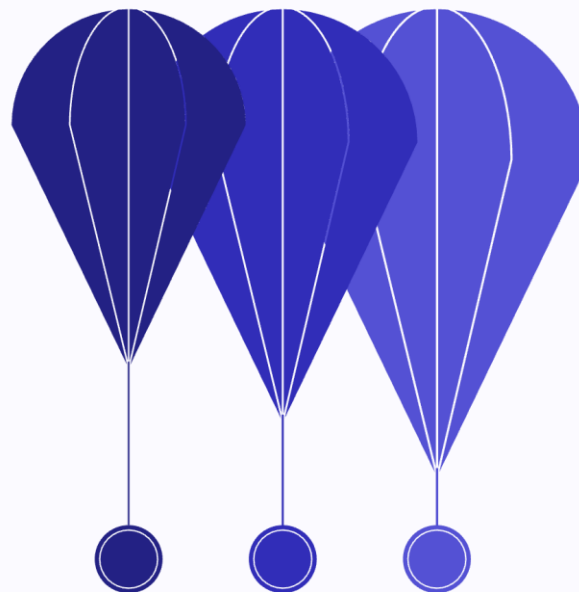
Mes 3

Segunda dosis de refuerzo



Cada 6 meses

Mantenimiento periódico



Lo que aprendimos

- PREVENT™ inicia, pero no termina la estratificación
- Lp(a) y ApoB identifican riesgo oculto
- CAC descubre aterosclerosis antes del primer evento
- Estatina → Ezetimibe → Evolocumab / Inclisiran
- La mejor angioplastia es la prevención años antes del infarto

6. Ray KK et al. *N Engl J Med.* 2020;382(16):1507-1519.



Development and validation of a new algorithm for improved cardiovascular risk prediction

Received: 21 July 2023

Accepted: 4 March 2024

Published online: 18 April 2024

 Check for updates

Julia Hippisley-Cox¹✉, Carol A. C. Coupland^{1,2}, Mona Bafadhel³,
Richard E. K. Russell³, Aziz Sheikh^{1,4}, Peter Brindle⁵ & Keith M. Channon^{6,7}

QRISK algorithms use data from millions of people to help clinicians identify individuals at high risk of cardiovascular disease (CVD). Here, we derive and externally validate a new algorithm, which we have named QR4, that incorporates novel risk factors to estimate 10-year CVD risk separately for men and women. Health data from 9.98 million and 6.79 million adults from the United Kingdom were used for derivation and validation of the algorithm, respectively. Cause-specific Cox models were used to develop models to predict CVD risk, and the performance of QR4 was compared with version 3 of QRISK, Systematic Coronary Risk Evaluation 2 (SCORE2) and atherosclerotic cardiovascular disease (ASCVD) risk scores. We identified seven novel risk factors in models for both men and women (brain cancer, lung cancer, Down syndrome, blood cancer, chronic obstructive pulmonary disease, oral cancer and learning disability) and two additional novel risk

Article

<https://doi.org/10.1038/s41591-024-02905-y>



Gracias

A photograph showing seven hands of different skin tones holding up large, colorful letters to spell out the word 'Gracias' (Thank you in Spanish). The letters are: 'G' (blue), 'r' (green), 'a' (red), 'c' (purple), 'i' (yellow), 'a' (blue), and 's' (pink). The hands are positioned below each letter, supporting it from underneath. The background is a plain, light gray.